GUIAS DE REFERENCIA

SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA

ACTUALIZACIÓN 2024

Dr. José Ramírez y Dr. Tony Ye

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA

Indicaciones generales

1. Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a pacientes se refieren para la atención de medicina especializada indicados por la Gerencia Médica.

2. Toda referencia debe incluir:
    - Nombre del centro de procedencia, nombre del médico que refiere y fecha.
    - Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral y escolaridad
    - Antecedentes patológicos, sintomatología tiempo de evolución y tratamiento recibido
    - Antecedentes personales no patológicos, transfusiones realizadas, uso de drogas ilícitas y alergia a medicamentos.
    - Antecedentes Heredofamiliares
    - Antecedentes Quirúrgicos
    - Examen físico, que incluya agudeza visual por medio de las cartillas de Snellen

3. **Justificación clara del motivo de referir a este paciente**. Diagnóstico claro por el cual se refiere al paciente, o en su defecto una impresión diagnóstica, que deje entrever la necesidad de resolver el caso en un segundo nivel de atención, y por qué se agotó la capacidad resolutiva del primer nivel.

4. **Los casos considerados como urgentes deben referirse directamente al Servicio de Urgencias y NO A LA CONSULTA EXTERNA.**

5. Los pacientes que lleguen al Servicio de Emergencias durante el tiempo extraordinario (De lunes a jueves de 4pm a 7am y viernes desde las 3pm hasta lunes 7 am); debido a alguna patología ocular aguda, deben ser enviados al hospital que cuente con oftalmólogo de disponibilidad durante este tiempo para su valoración. Durante este tiempo el paciente es responsabilidad del médico tratante y del Servicio de Emergencias.

Patologías oculares que deben ser referidas al Servicio de Emergencias

Referencias al servicio de Urgencias	✓ **Sospecha de Glaucoma Agudo** o Dolor ocular intenso unilateral o Congestión conjuntival severa o Midriasis media no reactiva a la luz (anisocoria) o Disminución de la agudeza visual y/o halos de luces o Cefalea inicialmente en hemicara, la cual se puede hacer universal o No responden a ningún analgésico o Náuseas y/o vómitos ✓ **Estrabismo traumático** o Realizar TAC de órbita con cortes finos (sagitales y coronales) y macizo facial con reconstrucción 3D ✓ **Estrabismo súbito** ✓ **Diplopía** o Definir si es monocular o binocular, en cual posición de la mirada se presenta y tiempo de evolución, así como la función pupilar o Realizar examen neurológico completo o Considerar en el diagnóstico diferencial las causas vasculares, neurológicas y musculares. o Considerar realizar exámenes de laboratorio y TAC cráneo con y sin medio de contraste ✓ **Pérdida de la visión súbita de CUALQUIER índole** o Adecuado interrogatorio de la historia clínica en relación con la perdida de la agudeza visual o Valoración de la agudeza visual por medio de las cartillas de Snellen o Consultar por presencia de fotopsias, miodesopsias, o perdida de campo visual, a fin de considerar diagnósticos de desgarros retinianos o desprendimientos de retina. ✓ **Quemaduras oculares con ácidos o base** o Realizar lavado ocular ✓ **Trauma ocular significativo de cualquier origen** o Referir ante cualquier trauma ocular importante. o Referir si presenta herida en ángulo nasal que comprometa la vía lagrimal

- No aplicar ningún colirio ni ungüento a la lesión.
-

✓ **Heridas penetrantes de ojo**

- Evitar colocación de parche compresivos
- No aplicar ningún colirio ni ungüento a la lesión.

✓ **Herpes Zoster con compromiso de rama del trigémino**

✓ **Celulitis post septal.**

- Se presenta con edema, eritema y datos inflamatorios peri orbitarios, con dolor a la movilización ocular.
- Realizar TAC de órbitas cortes finos (sagitales y coronales)

✓ **Uveítis aguda o crónicas reagudizadas**

- Dolor ocular intenso acompañado de ojo rojo y diminución de la agudeza visual.

✓ **Cuerpo extraño en córnea o conjuntiva**

- Presencia de cuerpo extraño en ojo por cortadura de metal o soldadura.
- Considerar si evento se encuentra cubierto por seguro laboral
- Si se logra extraer el cuerpo extraño se colocar un parche ocular con terramicina por 24 horas y luego iniciar lagrimas artificiales 1 gota cada 2 horas por 5 días.
- Si no se logra extraer el cuerpo extraño, se coloca un parche con terramicina por 24 horas, y se deberá comentar con médico oftalmólogo a considerar referir a la consulta externa para valoración.

✓ **Neuritis óptica y papiledema**

- Disminución de la agudeza visual acompañado de cefaleas, náuseas o vómitos y presencia de dolor ocular a los movimientos oculares
- Realizar examen neurológico completo
- Considerar en el diagnóstico diferencial de las causas neurológicas
- Considerar realizar exámenes de laboratorio y TAC cráneo con y sin medio de contraste

✓ **Queratitis infecciosa (úlceras corneales)**

- Sensación de cuerpo extraño con ojo rojo, dolor y perdida de agudeza visual, con presencia de lesión corneal blanquecina que tiñe con fluorosceína.
- Puede presentarse posterior a un trauma, caída de líquido, secundario a uso de lentes de contacto, posterior a episodio de conjuntivitis de larga evolución o antecedente de lesiones en hemicara por herpes zoster.
  .

	✓ **Epiescleritis y escleritis** o Se presentan con ojo rojo total o parcial, asociado a dolor ocular intenso o Pueden asociarse a enfermedades autoinmunes de fondo. ✓ **Conjuntivitis** o Se presenta cuadro con ojo rojo, secreción, molestias oculares sin alteración visual o A la exploración con hiperemia conjuntival, sin afectación corneal ni pupilar o Referir después de 5 días de tratamiento, sin respuesta adecuada.

CRITERIOS DE REFERENCIA CONSULTA EXTERNA - SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Tumores malignos de cualquier parte del globo o anexos	• Presencia de lesión sospechosa de malignidad, pigmentada o no, de bordes elevados e irregulares acompañada de vascularización y de crecimiento rápido.	Prioridad	No requiere	
Chalazión y orzuelo	• • Aumento de volumen circunscrito a nivel espesor de parpado superior o inferior • • Referir después de 7 días de tratamiento, sin respuesta adecuada.	Prioridad		• Debe recibir tratamiento previo con Tetraciclina oftálmica en ungüento, 1 aplicación HS y Fluorometalona, 1 gota QID.
Cataratas	Disminución de agudeza visual de forma lenta y	Cupo	Valorar agudeza visual con cartilla de Snellen	En caso de sospecha de catarata, con visión mejor a 20/60, referirse

	progresiva, con opacidad del cristalino.	(*Prioridad)	Valorar capacidad de observación del reflejo de fondo, a fin de determinar grado de opacidad del cristalino	inicialmente a Optometria *Referir con prioridad si presenta agudeza visual peor a 20/200 corregida con lentes en el mejor ojo, opacidad total del cristalino o si es ojo preferencial (ojo único)
Pterigión	Referir casos que se consideren de manejo quirúrgico en donde sobrepasen la región de limbo corneoescleral, causen molestias oculares y/o disminuyan agudeza visual.	Cupo		No referir si se encuentran asintomáticos, en estos casos se deberá indicar lubricantes tópicos, control y vigilancia de progreso en 1 año
Obstrucciones de la vía lagrimal	Epifora, con aumento de volumen en región del saco lacrimal acompañado de dolor.	Prioridad	No requiere	Considerar previamente necesidad de tratamiento antibiótico oral en caso de dacriocistitis.
Estrabismo	Consiste en la mala alineación de los ojos que causa desviación de la mirada, que se aparta del paralelismo normal.	Prioridad	No requiere	Referir con prioridad a niños
Queratocono y	Disminución de la agudeza	Prioridad	Valoración por	Considerar antecedente de

otras ectasias o degeneraciones corneales	visual, en ocasiones con opacidad corneal		optometría previamente	queratocono en familia
Perdida crónica de la agudeza visual	Referir pacientes con historia de disminución de agudeza visual de larga data.	Cupo	Valorar agudeza visual con cartilla de Snellen	
Blefaritis e irritaciones conjuntivales crónicas	Se presenta con engrosamiento de borde palpebral, eritematoso, con escamas en la raíz de las pestañas	Prioridad		Se recomienda realizar limpieza de párpados y pestañas (Champú No lagrimas) Compresas tibias Se le puede indicar fluorometalona 1 gota cada 4h, tetracicilina oftálmica en ungüento BID y gentamicina 1 gota cada 2 horas
Triquiasis y otras anormalidades de la posición de los párpados	Pestañas invertidas, que pueden estar en contacto con la superficie de la córnea.	Prioridad (*Urgencias)		Referir ante la sospecha de posible lesión corneal o presencia de ojo rojo persistente. *Referir a Urgencias en caso de presentar desepitelización o úlcera corneal.
Ectropión, entropión y otras	Eversión o inversión de los parpados (más frecuente en	Cupo		*Referir a Urgencias en caso de presentar desepitelización o úlcera

anormalidades de la posición de los parpados	parpado inferior)	(*Urgencias)		corneal.
Pingueculas y otras anomalías de la conjuntiva no tumorales	Engrosamiento conjuntival que no sobrepasa el limbo esclero corneal Referir solo si presentan molestias oculares	Cupo		Tratamiento en primer nivel de atención, se indicarán lubricantes y antinflamatorios no esteroideos tópicos. Se recomienda uso de gafas oscuras con protección de luz solar En caso de ser sintomático y causar molestias oculares referir a cupo.
Glaucoma Crónico	Antecedente familiar de glaucoma, o ceguera. Disminución de la agudeza visual.	Prioridad	Valoración previa por optometría Realizar test de agudeza visual y campimetría por confrontación.	
Retinopatía diabética y retinopatías asociadas a la edad	Todo paciente con diagnóstico de Diabetes mellitus tipo 1 o 2 requiere fondo de ojo al diagnóstico	Cupo		
Proptosis de globo ocular	Proptosis significativa unilateral del globo ocular (exoftalmos)	Prioridad	TAC de SNC y de órbitas cortes finos (sagitales y coronales) con y sin medio de contraste Laboratorios (Pruebas tiroideas)	